

# Sinusitis aguda y crónica: diagnóstico clínico y complicaciones orbitarias

---

## 1. Introducción y relevancia clínica

La **sinusitis** (o más propiamente *rinosinusitis*) corresponde a la **inflamación de la mucosa de los senos paranasales** y de la cavidad nasal, frecuentemente secundaria a una infección viral, bacteriana o a mecanismos inflamatorios crónicos.

Se clasifica según su duración en:

- **Aguda:** <4 semanas
- **Subaguda:** 4–12 semanas
- **Crónica:** >12 semanas (con o sin pólipos)

### Relevancia clínica

- Es una de las causas **más comunes de consulta en atención primaria** y de **uso de antibióticos** en Chile.
  - La mayoría son **virales autolimitadas**, pero un 0,5–2% progresa a infección bacteriana.
  - Las formas complicadas pueden comprometer **órbita, huesos craneofaciales o sistema nervioso central**, constituyendo urgencias ORL.
  - La **rinosinusitis crónica (RSC)** afecta la calidad de vida comparable a enfermedades crónicas como asma o artritis reumatoide.
- 

## 2. Fisiopatología y bases conceptuales

### 2.1 Anatomía funcional

Los senos paranasales son cavidades neumáticas revestidas por mucosa respiratoria que drenan a la cavidad nasal a través del complejo osteomeatal.

Se dividen en:

- **Maxilares** (los más grandes)
- **Etmoidales**
- **Frontales**
- **Esfenoidales**

El drenaje mucociliar normal depende de:

1. **Permeabilidad de los ostiums sinusales**
  2. **Función ciliar adecuada**
  3. **Características del moco**
- 

## **2.2 Mecanismo fisiopatológico**

Cualquier proceso que altere el drenaje normal o la ventilación del seno → acumulación de secreción → proliferación bacteriana.

**Fases:**

1. **Viral inicial:** congestión, edema mucoso y obstrucción de ostium.
  2. **Bacteriana secundaria:** crecimiento de flora patógena (*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*).
  3. **Inflamación crónica:** alteración de mucosa, biofilm bacteriano, posible componente alérgico o fúngico.
- 

## **2.3 Factores predisponentes**

- Infecciones virales respiratorias previas
- Rinitis alérgica o vasomotora
- Tabique nasal desviado o pólipos
- Tabaquismo activo o pasivo

- Inmunodeficiencias
  - Reflujo gastroesofágico
  - Fármacos (corticoides intranasales mal usados, quimioterapia)
- 

### 3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

#### 3.1 Rinosinusitis aguda viral (resfrío común)

Duración <10 días, sin empeoramiento.

Síntomas: congestión, rinorrea serosa o mucosa, dolor facial leve, febrícula.

---

#### 3.2 Rinosinusitis bacteriana aguda (RSBA)

**Criterios clínicos mayores (MINSAL / EPOS):**

- Rinorrea purulenta anterior o posterior
- Obstrucción nasal
- Dolor o presión facial
- Hiposmia o anosmia

**Sugerente de origen bacteriano:**

- Síntomas >10 días sin mejoría, o
  - Empeoramiento tras mejoría inicial (“doble empeoramiento”), o
  - Fiebre alta (>38°C) + secreción purulenta + dolor facial >3 días.
- 

#### 3.3 Rinosinusitis crónica (RSC)

Definida por **síntomas ≥12 semanas** + evidencia endoscópica o radiológica de inflamación.

**Síntomas cardinales:**

- Obstrucción nasal persistente
- Rinorrea mucopurulenta
- Dolor o presión facial
- Disminución del olfato

#### **Tipos:**

1. **Con pólipos nasales (RSCcPN):** inflamación eosinofílica, frecuente en asmáticos.
2. **Sin pólipos (RSCsPN):** más asociada a infección bacteriana crónica o alteración estructural.

---

### **3.4 Diagnóstico diferencial**

| <b>Entidad</b>                     | <b>Diferencias principales</b>                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Rinitis alérgica</b>            | Moco claro, estacionalidad, sin fiebre ni dolor facial. |
| <b>Migraña o cefalea tensional</b> | Dolor sin congestión ni rinorrea.                       |
| <b>Neuralgia facial</b>            | Dolor breve, eléctrico, localizado.                     |
| <b>Sinusitis dental maxilar</b>    | Dolor unilateral postprocedimiento dentario.            |

---

## **4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos**

### **4.1 Diagnóstico clínico**

- En la **sinusitis aguda**, el diagnóstico es **clínico**.

- En **casos complicados o crónicos**, se requieren estudios de imagen y microbiología.

---

## 4.2 Estudios complementarios

| Examen                                                  | Utilidad                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endoscopía nasal                                        | Evalúa drenaje, secreción purulenta, pólipos o alteraciones anatómicas.                              |
| TAC de senos paranasales (coronal)                      | Estudio de elección en RSC o sospecha de complicación. Muestra opacificación o engrosamiento mucoso. |
| Cultivo de secreción sinusal (por punción o endoscopía) | En infecciones refractarias a antibióticos o inmunocomprometidos.                                    |
| Radiografía simple                                      | Obsoleta; baja sensibilidad.                                                                         |
| Exámenes generales                                      | En sospecha de inmunodeficiencia o alergia (IgE, eosinofilia).                                       |

---

## 5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

### 5.1 Sinusitis aguda viral

- **Sintomático:** analgésicos (paracetamol, ibuprofeno).
- **Lavados nasales con suero fisiológico.**
- **Corticoides nasales tópicos** (budesonida, mometasona) para congestión.
- **No antibióticos.**

---

## 5.2 Sinusitis bacteriana aguda (SBA)

### A. Tratamiento antibiótico

Indicaciones:

- Síntomas >10 días sin mejoría.
- Dolor facial intenso, fiebre >38°C.
- Empeoramiento tras mejoría inicial.

**Fármaco de elección (MINSAL):**

- **Amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 mg VO c/12h por 7–10 días.**

Alternativas:

- **Cefuroxima axetilo 500 mg c/12h.**
- **Claritromicina 500 mg c/12h (alérgicos a penicilina).**

---

### B. Tratamiento sintomático

- **Lavado nasal con solución salina hipertónica.**
- **Corticoide nasal tópico (fluticasona, budesonida) por 2–3 semanas.**
- **Descongestionantes tópicos: máximo 3–5 días.**
- **Analgesia y reposo relativo.**

---

## 5.3 Sinusitis crónica (RSC)

### A. Tratamiento médico

1. **Corticoides nasales tópicos: base del manejo (uso continuo).**
2. **Lavados nasales diarios con solución salina.**

3. **Antibióticos prolongados (3–4 semanas)** en exacerbaciones agudas (amoxicilina/clavulánico o levofloxacin).
4. **Corticoides orales breves (prednisona 40 mg/día x 5–10 días)** en RSC con pólipos.
5. **Tratamiento de comorbilidades:** alergia, asma, reflujo, tabaquismo.

## B. Tratamiento quirúrgico

### Cirugía endoscópica funcional de senos paranasales (CEFS):

- Indicada en RSC refractaria a tratamiento médico óptimo por 3 meses.
- Permite restaurar ventilación y drenaje, y eliminar pólipos.

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones ocurren principalmente en **sinusitis etmoidal y frontal**, por su proximidad a la órbita y cavidad craneal.

| Complicación                             | Manifestaciones                                           | Manejo                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Celulitis preseptal</b>               | Edema palpebral sin afectación ocular.                    | Antibióticos VO.                           |
| <b>Celulitis orbitaria</b>               | Dolor, proptosis, limitación ocular.                      | Hospitalización + antibióticos EV.         |
| <b>Absceso subperióstico u orbitario</b> | Proptosis marcada, fiebre, disminución de agudeza visual. | Urgencia quirúrgica ORL + antibióticos EV. |
| <b>Trombosis seno cavernoso</b>          | Compromiso bilateral, pares craneales III–VI.             | Urgencia vital (UCI).                      |

|                                              |                                         |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Absceso epidural o cerebral</b>           | Cefalea, fiebre, focalidad neurológica. | Neurocirugía + antibióticos prolongados. |
| <b>Osteomielitis frontal (tumor de Pott)</b> | Edema de frente, dolor, fiebre.         | Tratamiento quirúrgico.                  |

#### **Pronóstico:**

Excelente en cuadros agudos tratados precozmente.

En RSC, requiere manejo prolongado, pero control adecuado mejora la calidad de vida.

## **7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM**

### **Perlas clínicas**

1. **>10 días de síntomas o empeoramiento → sospechar sinusitis bacteriana.**
2. **Amoxicilina/clavulánico** es el antibiótico de primera elección.
3. **No usar antibióticos en resfríos virales (<10 días).**
4. **Corticoides nasales** son esenciales en el manejo de RSC.
5. **Compromiso ocular o neurológico = derivación urgente a ORL.**
6. **RSC con pólipos** se asocia a asma y sensibilidad a AAS (tríada de Samter).

### **Errores comunes**

- Confundir resfrío viral con sinusitis bacteriana.
- Indicar antibióticos sin criterios clínicos.
- Mantener descongestionantes tópicos por tiempo prolongado.
- No tratar comorbilidades (alergia, desviación septal, reflujo).



- No derivar ante signos de complicación orbitaria o neurológica.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **rinosinusitis** es una inflamación de la mucosa nasal y sinusal, generalmente viral y autolimitada.
2. El diagnóstico de **sinusitis bacteriana aguda** se basa en **síntomas >10 días o doble empeoramiento**.
3. El tratamiento de elección es **amoxicilina/ácido clavulánico por 7–10 días**.
4. La **rinosinusitis crónica** requiere **corticoides nasales y lavados salinos** prolongados.
5. Las **complicaciones orbitarias o neurológicas** son urgencias ORL.
6. En RSC refractaria, se indica **cirugía endoscópica funcional**.
7. **No usar antibióticos empíricos** en infecciones virales simples.